

ANA CLAUDIA DE SOUZA

NÓS E OS OUTROS

PSICOLOGIA EXISTENCIALISTA
CASOS PSICOTERAPÊUTICOS TRABALHADOS

LISBON
INTERNATIONAL PRESS

Caso 01:

Abandono familiar e pânico

Ao longo de um processo psicoterapêutico de três anos, trabalhamos o atendimento psicoterapêutico desta paciente, que contava na ocasião 45 anos. Era formada no terceiro grau há mais de 20 anos, mas não exercia a profissão. Se dedicava a cuidar da filha de seis anos, e a alguns trabalhos voluntários relacionados a um grupo de estudos com o qual ainda mantinha vínculo desde a época da universidade. Era natural do interior, mas morava há muitos anos longe da cidade natal da qual saiu para estudar. Estava casada há 20 anos. Seu marido também tinha terceiro grau e era funcionário público concursado. Os pais viveram muitos anos no interior e depois passaram a dividir-se entre a cidade atual da paciente e a cidade originária deles. Ela tinha também dois irmãos mais novos, ambos casados, um deles já no segundo casamento, com filhos e com formação superior, os quais viviam em outras cidades do seu estado. Os pais já haviam vivido em casas separadas algumas vezes em virtude de dificuldades emocionais de ambos, o pai envolvido com alcoolismo e a mãe que já havia inclusive tido internação psiquiátrica.

A paciente já vinha sofrendo de longa data, tendo passado por vários anos de outros atendimentos terapêuticos,

mas sem conseguir superar suas dificuldades emocionais. Quando chegou à terapia, estava padecendo de enrijecimento no corpo, tensão no maxilar, dor nos braços e pernas, irritação; tremor no corpo todo, tremedeira, sensação de fraqueza; frio na barriga, sudorese no corpo todo; sensação de transparência: medo, estado de alerta; dispersão, inquietação, agitação, logorreia; turbilhão de pensamentos: precipitação de ideias; choro retido/com-pulsivo, nó na garganta; respiração curta/ofegante: pal-pitações, sufocamento; pressão no peito; náusea, enjoo, perda de apetite, bolo na garganta; pressão na cabeça; calor/rubor facial; insônia, dificuldade para adormecer, intermitência, cansaço ao acordar; vontade de morrer, sendo que no passado já padecera de obsessão por sui-cídio com pensamentos de se atirar de prédio; e exaus-tão após o acesso: corpo pesado, sonolência e cansaço. Estes sintomas vinham ocorrendo no mínimo a cada dois dias e no intervalo entre os acessos padecia de estado de tensão/ansiedade constantes.

Para conter os acessos, a paciente foi encaminhada à consulta com psiquiatra, com relatório descrevendo seus sintomas e outros tratamentos médicos de modo a buscar um apoio químico que contivesse a severidade dos seus acessos – que a impedissem de levar suas atividades coti-dianas com normalidade. O psiquiatra que a atendeu prescreveu Oxalato de Escitalopram 15 mg e Clonazepam 0,5 mg para usar até 1 mg ao dia em caso de necessidade.

Alguns dias após iniciar a medicação, os acessos reduziram um pouco em frequência e intensidade, e com o transcorrer do processo psicoterapêutico, com uso coadjuvante da medicação, estes ficaram bastante reduzidos, com a paciente vindo a ter uma condição emocional de normalidade. Em épocas anteriores a este processo psicoterapêutico, a paciente já havia precisado recorrer a medicação, entre elas: Maprotilina, Clobazan, Lorazepan, Valproato de Sódio, entre outros.

As queixas que a fizeram recorrer ao processo psicoterapêutico eram de diversas ordens. Uma delas era a grande ansiedade na qual entrava ao ter que lidar com certas circunstâncias na convivência com sua progenitora, que tinha sérios problemas: ameaçava matar o marido, acusava-o de ter amantes, de traficar drogas, etc., e recusava-se a usar medicamento psicotrópico. A paciente tinha muito medo do que a mãe pudesse fazer ao pai ou a si própria, e isso fazia com que não conseguisse se desligar dos cuidados e atenção à mesma.

Também tinha bastante ansiedade na relação com a filha de quatro anos, que tinha uma saúde frágil e precisava recorrentemente de atendimentos de emergência médica, por ter convulsões. Quando menor, a filha também já tinha padecido de forte alergia alimentar, o que colocava a ela e ao marido em intermináveis cuidados.

Com o marido, a paciente também tinha várias dificuldades de relacionamento, com vários atritos que a levavam

a descontrola emocional a ponto de ter que deitar-se no chão para conseguir controlar o corpo que tremia muito.

Vinha com planos de retomar a atividade profissional na qual havia se formado, mas toda essa turbulência na vida de relações, bem como suas inseguranças que já vinham de longa data a impediam de conseguir atuar, pois entrava em forte ansiedade e desespero. Experimentava sua vida inviabilizada em vários aspectos, como mãe, como profissional, como esposa, como irmã e como filha, como se existisse uma condenação que a impedia de poder se viabilizar e ser feliz.

Como todo processo psicoterapêutico dentro da Metodologia Científica Existencialista parte do presente do fenômeno, a atuação no caso da paciente iniciou com a localização e orientação dela frente às condutas possíveis com os progenitores. Como o pai dela encontrava-se atualmente em melhor condição emocional, foi orientada a recorrer a ele e aos irmãos para que dividissem os cuidados com a mãe, o que eles fizeram minimamente, gerando maior tranquilidade para a paciente haver-se com seu marido e filha.

Fomos localizando-a em sua dificuldade de transcender para uma vida própria, pois apesar de ter marido, filha e formação profissional, ainda se movia fortemente exigida pelas demandas familiares, mesmo em momentos em que as situações da família de origem encontravam-se mais sob controle, pois a mãe e o pai por vezes acertavam-se e

transcorriam-se alguns meses em relativa pacificação. Ela precisou perceber que se mantinha em órbita circular uniforme em torno da família de origem, o que gerava alguns dos transtornos que vivia tanto com o marido como com a filha. Também fomos trabalhando a necessidade de acerto na comunicação com o marido, de modo que ela pudesse voltar-se e contar mais com ele.

Em relação à situação de saúde da filha, que trazia bastante sofrimento para a paciente e o marido e fazia com que vivessem as voltas com os cuidados com a menina, precisávamos dar encaminhamento, pois enquanto a menina se encontrasse num quadro delicado de saúde, a situação da mãe seguiria de dedicação praticamente exclusiva à filha, agindo mais como sua cuidadora do que como mãe. Para isso, procedemos à iniciativa de descrever com a paciente todo o histórico de saúde da filha e formulamos um relatório que foi levado em mãos para as consultas da filha com os especialistas que a tratavam. Os médicos fecharam o diagnóstico que propunha intervenção cirúrgica de retirada das amígdalas, concluindo que as recorrentes amigdalites eram responsáveis pelas convulsões da menina, conforme a hipótese que havíamos levantado. Após a cirurgia bem-sucedida, a menina nunca mais teve convulsões e sua condição de saúde foi sistematicamente melhorando, até que se tornou saudável.

Estes avanços no quadro de saúde da filha permitiram que fizéssemos sessão com a paciente e o marido

trabalhando a apropriação da situação atual e a localização quanto às possibilidades reais que o momento trazia para a vida cotidiana deles. Agora poderiam dedicar-se aos seus outros perfis, de marido e mulher, no caso da paciente também de profissional, etc., já que até então, por força das circunstâncias, funcionara mais como cuidadora ou enfermeira de sua filha.

Todas estas providências em relação ao compartilhamento das demandas da mãe com os irmãos e às situações de saúde da filha fizeram com que o cotidiano deles ficasse mais tranquilo, seja pela diminuição das lidas com a progenitora da paciente, que inclusive passou tempos na cidade dos outros filhos, seja pela normalidade de cuidados que a filha passou a requerer. A partir deste momento, as novas situações emocionais nas quais a paciente passou a debater-se tanto com o marido e a filha quanto com sua progenitora, evidenciaram-se como não mais reativas à situação presente – quer dizer, não encontravam ancoragem nos acontecimentos materiais atuais.

Um dos episódios em que constatamos essa incompatibilidade entre o acesso emocional e a circunstância atual foi quando ela e a filha estavam em casa e a filha queria dar banho na boneca, estavam brincando na pia do banheiro e derramaram água no chão. O marido havia saído por uns minutos e a paciente enxugou o chão, para que não escorregassem, com um pano de pia que estava para descartar. Quando o marido voltou ao apartamento, a filha já estava

brincando de outra coisa e ele sentiu falta e perguntou pelo pano de pia, pois ela descartara e havia esquecido de colocar outro no lugar. Diante da pergunta dele, a paciente ficou muito tensa, com palpitações, pressão no peito, frio na barriga, tremor, sudorese nas mãos, etc., gaguejou para falar, antecipando que ele ficaria furioso com ela, que brigariam na frente da filha, e, ao fundo, vinha o sentimento de que ele a abandonaria por fazer as coisas erradas. Nervosamente, ela explicou o ocorrido e ele apenas referiu que já havia trocado o pano naquela semana. Ela foi se acalmando e saiu da atmosfera de medo.

Outro episódio ocorrido com o marido foi quando ele se levantou pela manhã para ir trabalhar, foi preparar a mochila com a roupa de futebol para o jogo da noite e perguntou a ela onde estava a camiseta que havia deixado atrás da porta. A paciente gelou com a pergunta, teve palpitações, pressão no peito, tremedeira, etc., e não sabia o que responder porque não lembrava se tinha mexido na camiseta. Levantou-se da cama e perguntou a ele quando viu a camisa pela última vez, e constataram que ele havia deixado pendurada atrás da porta de entrada. Ficou aliviada por não ter sido um erro dela que tivesse esquecido de cuidar da camiseta. Como ele tinha sido ríspido ao perguntar pela camiseta, voltou e pediu-lhe desculpas e aos poucos ela voltou à normalidade emocional.

Episódios como estes ocorriam inúmeras vezes por semana na relação com o marido, e a experimentação de

fundo que sempre se repetia era que iriam se desacertar a ponto de se separarem e que ela iria ficar sozinha no mundo. Essa mesma experimentação de solidão ocorria na relação com as outras pessoas.

Com a filha ocorreram vários episódios, nos quais ocorria de experimentar a situação da filha como sendo a repetição da situação e do sofrimento dela, paciente, quando menina. Uma dessas situações foi quando a filha estava no plantão de férias e pediu para ir para a escola com fantasia de personagem de desenho animado, e, quando chegaram na escola, as coleguinhas olharam-na de fantasia e disseram que não poderia estar vestida assim. A paciente teve um acesso com palpitações, sufocamento, frio na barriga, pressão no peito, etc., experimentando que a filha ficaria excluída entre as amigas, e não saberia defender-se assim como ela não sabia quando era pequena. Saiu da escola muito pensativa, se cobrando ser descuidada como uma mãe que deixava a filha abandonada, malculada e que havia criado problema para a filha deixando-a ir para a escola de forma inapropriada, como a mãe fez diversas vezes com ela quando era criança.

Outra situação que exemplificou as inseguranças da paciente foi quando ela e a filha estavam brincando de se esconder, no parque. Na sua vez de esconder-se, foi num lugar um pouco longe e a filha não a achou, cansou de procurar e se sentou no balanço. Quando ela se aproximou da filha, a menina comentou que pensou que a mãe tivesse

ido embora. A paciente ficou muito emocionada, com vontade de chorar, ao experimentar que a filha estivesse se sentindo abandonada como ela se sentia quando menina.

Com a progenitora da paciente, os episódios também tinham esta conotação de abandono. Numa situação, a mãe dela que estava noutra cidade com um dos filhos, ligou-lhe para dizer que queria ver a neta e que viria à cidade sozinha. A paciente entrou em pânico achando que a mãe poderia vir e apossar-se da neta. Ao mesmo tempo ficou insegura do que diria à mãe para dissuadi-la de vir, temia desagradar a progenitora, que poderia vir a deixar de gostar dela e abandoná-la. Num outro episódio, a mãe sugeriu que ela e sua filha fossem com eles, pai e mãe da paciente, de carro, ao aniversário da outra neta, sobrinha da paciente. O pai dirige mal e ela tem muito medo, mas não sabia como dizer à mãe que não poderia ir ao aniversário, temendo que a mãe se chateasse e ao fim a abandonasse. Estas situações eram muito corriqueiras e cotidianas, e de longa data.

Anos antes, a paciente tinha sofrido numa situação que seria cômica se não fosse desesperadora para ela. Ela e a mãe estavam no seu apartamento e ela queria que a mãe fosse ao médico para buscar medicamento porque não estava bem emocionalmente, a mãe teimou que não iria e saiu porta afora. A paciente desesperou-se na clara convicção de que a mãe iria perder-se no mundo e saiu pelo meio da rua correndo atrás da mãe. Depois de correr algum tempo, encontrou a mãe sentada tomando suco.

Esta experimentação de solidão ocorria também em situações sociais. Numa situação foi convidada pela mãe de uma amiguinha da filha a ir de carona com ela para a festa da escola que ocorreria em outro bairro. Desde o momento em que acordou para arrumar-se e aguardar a carona, já se experimentou tensionada; quando a moça chegou com o marido, a tensão aumentou trazendo outros sintomas, e, durante todo o trajeto até a festa, não conseguia conversar com o casal, com medo de dizer alguma coisa que fosse desagradá-los. Chegando na festa, tinha esquecido de levar um brinquedo que a escola havia solicitado e, ao ver que as outras crianças tinham levado, ficou com muito medo do que iriam fazer com a filha por não ter o brinquedo. Precisou entregar um objeto à professora, algumas mães a chamaram para juntar-se a elas e, aos poucos, conseguiu ir saindo da situação emocional de forte tensão.

Nas situações de seu trabalho, também ocorriam episódios com o mesmo teor: ao cometer algum erro, entrava em pânico antecipando poder ser criticada pelos colegas de trabalho e considerada inadequada para o trabalho, e como consequência seria abandonada, descartada e perderia o emprego. Essa insegurança tornava seus dias de trabalho bastante tensos, vivendo sempre em situação de teste frente aos colegas.

Ao levantarmos estes e outros episódios, foi ficando evidente que a paciente tinha um forte medo de ser abandonada, quer fosse pelo marido, quer fosse pela mãe, pelos

colegas de trabalho, pelos irmãos, etc. Como nenhuma destas situações tinha ancoragem em termos de realidade presente, aparecia a grande incompatibilidade entre a reação emocional da paciente e a situação objetiva. Ao compreender isso, foi percebendo que estes medos não se sustentavam, pois apesar de se desacertar com o marido, vinham juntos há 20 anos e eram um para o outro um porto seguro em relação às suas famílias de origem, que eram ambas muito complicadas. Foi percebendo que as implicações do marido, ao contrário de serem por querer livrar-se dela, ocorriam porque gostaria que ela fosse mais companheira, coisa que não ocorria satisfatoriamente por ter medo de posicionar-se, o que o deixava irritado por experimentar-se sozinho, sem contar com ela para pensar e decidir as coisas.

Em relação à filha, também foi sendo localizada a diferença entre a situação dela quando criança e a de sua filha, que era uma filha com pais dedicados, cuidadosos, primorosos na atenção a ela, não havendo elementos de realidade que pudessem levar a filha a experimentar-se no risco de ser abandonada, pois em nenhum dia de sua vida tinha estado distante dos pais. Mostramos à paciente que o sofrimento que estava atribuindo à filha era o sofrimento do qual ela padecera quando menina, e que não poderia contrabandear tais elementos para a situação da filha. Assim, foi identificando a diferença entre os contextos delas e foi conseguindo avançar como mãe na relação com a filha.

Na relação com a progenitora, fomos verificando e localizando a paciente de que padecia do medo de abandono por parte da mãe desde que era muito pequena, e que era ainda a correlação com esse passado que a assustava quando estava diante da mãe, embora hoje fosse uma mulher e não mais a menina que passou por uma série de situações nas quais se experimentou abandonada.

Fechamos a compreensão psicoterapêutica da situação atual da paciente como uma pessoa que constituiu-se no medo de perder a família e ficar no abandono, sendo que o medo ocorria tanto em relação à família de gênese quanto em relação à família atual. E, como sempre acontece na constituição da personalidade, para que a paciente padecesse desse medo atualmente era necessário que tivesse constituído um saber de ser no medo do abandono a partir de acontecimentos antropológicos e sociológicos na gênese de sua personalidade. Portanto, para que fosse possível desmontar o medo do abandono no momento atual, precisaríamos levantar as situações de gênese que sustentavam este saber de ser, conforme nos guia a metodologia de intervenção psicoterapêutica.

Identificamos que, desde a primeira infância, a paciente passou por diversas situações que eram difíceis de ser compreendidas por uma criança. Os pais brigavam com muita frequência, o pai era alcóolatra e a mãe padecia de fortes descontroles emocionais. Quando a paciente tinha cinco anos, os pais se mudaram para um estado distante

da cidade natal dela, para tentar a vida na agricultura, que tinha sido a atividade do pai quando mais moço.

Nesse outro estado, um dos episódios de que a paciente se recordou foi o de uma noite em que ouviu os pais discutindo e a mãe dizendo que iria embora. Ela estava deitada e não conseguia dormir devido à discussão e, quando ouviu a mãe dizer isso, sentiu-se congelada, sem conseguir mexer-se na cama. No dia seguinte, acordou e viu que a mãe estava arrumando uma mala. Assustada e sem saber o que estava acontecendo, ficou sentada no sofá vendo a movimentação da mãe. Mais tarde o pai saiu com ela, o irmão e a mãe de carro e foram até a rodoviária. A mãe estava com a mala na mão e foi em direção ao ônibus deixando para trás a paciente, o pai e o irmão. A paciente se desesperou e saiu correndo em direção à mãe, se agarrando nas pernas dela. O pai foi tirá-la e a mãe disse que deixasse, e levou-a junto na viagem de ônibus, apenas com a roupa do corpo. Elas viajaram por cerca de três dias e chegaram à cidade natal dela, e, na chegada, a mãe levou-a até a casa da avó paterna, e como a mãe não tinha boa relação com a sogra, embora a paciente ainda não soubesse disso, bateu na porta e disse que a menina ficaria ali, virou as costas e foi embora.

A paciente pensa que deve ter ficado na casa da avó paterna por cerca de seis meses, pois começou sua vida escolar numa escola particular perto dali. Ela não tinha um quarto, as coisinhas que a avó lhe deu, cadernos e

lápiz, ficavam empilhadinhas numa cadeira, e dormia num dos quartos de hóspedes da casa. A avó e uma tia paterna que vivia ali a tratavam muito bem, a casa era confortável, mas sentia muita falta de sua mãe, não tinha notícias dela. Lembra de ter falado ao telefone com ela umas duas ou três vezes e em outras situações, nas quais o telefone tocava e a avó perguntava à empregada quem era, quando identificavam ser a mãe, desligavam o telefone. Ela entendia que “ela” que a empregada referia era a mãe, e que não a deixavam falar com a paciente. Também não tinha contato com o pai e o irmão, não sabia o que havia sido feito deles.

Numa ocasião, a tia veio conversar com ela e disse que a avó iria pedir a guarda dela ao juiz e que deveria dizer que queria ficar com a avó. Na sequência desse episódio, a mãe veio buscá-la, após saber que a avó tinha entrado com processo requerendo a guarda dela. Foi morar com a mãe num porão de uma casa, com móveis e objetos improvisados. A mãe estava nos últimos meses de gravidez da irmã da paciente. Ajudava a mãe nos trabalhos domésticos e, quando a mãe ia trabalhar, ficava inúmeras tardes sozinha neste porão ou na casa da vizinha do andar de cima. Lembrava que a mãe a trocou de escola e a deixava lá muito cedo pela manhã, quando ainda não tinha ninguém, nem o vigilante, e ela ficava sozinha brincando pelo parquinho até que o vigilante, e depois as crianças, comessem a chegar. Sentia-se muito constrangida nessa escola e

começou a ter dificuldades com aprendizagem. Na sequência, deixou de morar com a mãe, que a levou para uma cidade do interior na casa da avó materna, onde moravam também alguns tios e primos. Ficou por lá, trocou novamente de escola e ficava solta pelas ruas e quintais com as outras crianças e com os animais de estimação. A mãe vinha à casa da avó materna em alguns finais de semana, mas geralmente não interagiam, a mãe ficava na cozinha conversando com os adultos. Os parentes por parte da mãe eram bastante complicados, na casa de uma das tias na qual passou as férias também presenciou muitas brigas e alvoroços, tal qual ocorria na casa dela quando os pais viviam juntos.

Por volta dos sete anos da paciente, a mãe a buscou na avó materna e a levou para uma casa na qual reencontrou o pai e o irmão, que não sabia por onde tinham andado, além da irmã recém-nascida. Nesse momento, a casa já era melhor porque, depois veio a saber, a mãe abriu um processo contra o pai do marido, para que o pai da paciente recebesse indenização por ter trabalhado a vida toda na agricultura com seu progenitor, sem que tivesse adquirido nada com esses vários anos de trabalho. Foram indenizados com a casa por não haver recebido salário adequado e nem os direitos trabalhistas. Mesmo tendo voltado a estar com sua família, a vida nunca foi boa para eles. Os pais seguiam brigando muito, a mãe cobrava muito do pai em relação à família dele, nunca se reconciliou com a sogra

e o sogro, e o pai se acentuava cada vez mais no uso de álcool. Embora eles nunca tivessem se separado de fato, as ameaças de separação eram constantes durante toda a infância da paciente e até os dias atuais a mãe ainda ameaçava ir embora, e a paciente sempre ficou apavorada com a possibilidade de sua mãe sumir no mundo. Essas ameaças fizeram com que durante toda a sua infância e adolescência a paciente vivesse buscando corresponder às expectativas da mãe, de modo a não a chatear e correr o risco de ela ir embora. Esse medo era alimentado pela mãe, que além de brigar com o pai da paciente, brigava com eles e dizia que os filhos a enlouqueciam e que ela não aguentava mais. Esse discurso era recorrente, quer diante de um vaso que eles quebrassem, quer de uma arrumação da casa que não fizessem ou de um telefonema recebido que esquecessem de avisar.

Todo esse contexto antropológico foi mais do que suficiente para fazer com que a paciente estruturasse a sua personalidade no saber de ser no abandono, pois a estruturação da personalidade desdobra da apropriação das experiências vividas na primeira, segunda infância e adolescência, e faz com que a pessoa se estabeleça numa certeza a respeito do seu ser. Assim, a certeza na qual a paciente se estabeleceu foi de que, diante de qualquer deslize que cometesse, ou a qualquer momento, podia ocorrer de ser abandonada, aos moldes do que experimentou tendo acontecido quando se agarrou às pernas da

mãe na rodoviária e quando foi deixada na casa da avó paterna sem saber do paradeiro da família.

Uma história triste onde os adultos bastante complicados e conturbados emocionalmente, ignorando totalmente que a personalidade se estrutura a partir das experiências vividas, não tinham o cuidado de esclarecer minimamente às crianças o que estava ocorrendo, fazendo assim com que a paciente se estabelecesse fortemente neste saber de ser no abandono.

Após o levantamento de toda essa situação de gênese da personalidade, montamos a compreensão psicoterapêutica do caso, que consistia no medo de perder a família de gênese bem como a família atual, por ter formado a personalidade no saber de ser no abandono, e as situações de hoje fazerem correlação noemática com as situações de gênese. Quer dizer, as situações aparecem para a paciente como semelhantes, embora se indo aos detalhes das situações, elas não tenham efetivamente as mesmas propriedades.

Este foi o trabalho que se seguiu com a paciente, fazê-la localizar-se das correlações noemáticas, mas das diferenças dos contextos antropológicos atual e de gênese, de modo que ela pudesse tomar distância das situações e, sem confundi-las, deixasse de se afetar como anteriormente. Em síntese, a paciente precisava passar a ver sua situação a partir das possibilidades da adulta que ela era, pois acabou por ficar presa no saber de ser da menina que

ela foi, sem conseguir acompanhar e apropriar-se dos progressos objetivos do percurso de sua vida.

Os medos todos que a paciente tinha, que se relacionavam ao abandono, encontravam então ancoragem na sua formação da personalidade. Seja o medo de ser abandonada pelo marido, da filha sentir-se abandonada como ela se sentia quando menina, de ser abandonada pela mãe, pelas colegas de trabalho, etc.

Em relação à situação da filha, a mesma distinção entre o presente e o passado foi sendo trabalhada mostrando a diferença entre o contexto dela quando menina e o contexto de sua filha, de modo que ela se localizasse de que a filha tem pais com boa formação intelectual, que vivem noutro momento histórico, noutra cidade que a cidade do interior onde ela vivia, que a filha frequenta uma boa escola, tendo acompanhamento cuidadoso dos pais quanto aos estudos, quanto à saúde, etc., ficando impossível que num contexto totalmente diferente daquele em que a paciente fora criada, a filha dela pudesse vir a ter a mesma experimentação de ser que ela tivera quando menina e na qual aprisionou-se.

Este processo de comparação entre os episódios atuais e os episódios de gênese, perpassando episódios em seus diversos perfis, foi repetido inúmeras vezes até que ficasse suficientemente desmontada a confusão que a paciente fazia entre as situações, com o objetivo de estabelecê-la numa nova inteligibilidade de sua situação e de suas possibilidades atuais.

Com estas localizações a paciente foi avançando nas diversas relações. Foi deixando de perceber-se na filha, vendo que a menina e ela têm histórias totalmente distintas. E trabalhamos também de modo a mostrar que a história dela, por mais que tenha sido composta por uma série de acontecimentos dramáticos, também é distinta da história dos pais, por isso o alcoolismo do pai e o enlouquecimento da mãe não têm como se repetir na família atual dela, bem como os desacertos entre ela e o marido não precisam repetir os desacertos dos pais dela, que não tinham condição de fazer muito melhor do que fizeram por conta de todo o contexto do qual resultaram.

Para que a paciente compreendesse ainda mais as singularidades e as condições antropológicas e sociológicas como determinantes da constituição da personalidade, levantamos alguns elementos da história dos pais. Os pais vinham de uma cidade do interior muito pequena, a mãe era a terceira filha do segundo casamento de seu pai, e tinha vários outros irmãos por parte de pai. A mãe dela ficou viúva e trabalhava de empregada na casa da sogra, e acabou deixando uma das filhas para a sogra criar devido à necessidade/escassez em que viviam e essa filha veio a se suicidar na juventude. A mãe da paciente ficou muito marcada por esse episódio e sempre cobrou de sua progenitora ter abandonado uma das filhas. Na casa em que a mãe foi criada com os irmãos por parte de pai, que eram mais velhos, aconteceu de viver em grande

escassez, de passar por situações de exposição a elementos sexuais. Os irmãos eram alcoólatras e um dos irmãos assassinou uma pessoa; fazia parte do contexto frequentar a zona de meretrício, trair as mulheres, estupraram uma mulher, enfim, contexto antropológico suficiente para fazer com que a mãe fosse complicada psicologicamente. E não obstante essa complicação, ainda conseguiu se fazer professora, sair da cidade natal, casar e criar os filhos, inclusive se esforçando para que todos, incluindo a paciente, tivessem terceiro grau. Ao resgatar a história da mãe, buscamos que a paciente saísse do plano moral e pudesse compreender que a mãe fez o melhor que pôde dentro das condições dadas, mesmo que com muitos equívocos, como todo ser humano.

O pai da paciente vinha de uma situação também sofrida, era o filho mais novo de uma família em que os irmãos puderam estudar, mas por ter sido considerado alguém limitado para os estudos, acabou ficando na agricultura e depois no trabalho como caminhoneiro. Isso provocava constrangimento na paciente, que tinha a família do pai como uma família ilustrada e se sabia a filha do homem que não estudou. Para desmontar o preconceito dela relativamente ao pai, trabalhamos em qual objetivo as pessoas buscam ao estudar, que é ter condições materiais para poder viabilizar uma família, sendo o estudo um meio e não um fim em si mesmo. Fizemos o levantamento da situação de todos os seus primos e comparamos com a

situação dela e dos irmãos, mostrando que através do trabalho realizado pelo pai, alcançou para ela e seus irmãos condições similares às proporcionadas aos primos.

Com essas localizações a paciente foi gradativamente se desprendendo de suas reflexões cúmplices a respeito de seus pais, e começou pela primeira vez a perceber a sua mãe sem desqualificá-la como sempre fazia e o mesmo ocorreu com seu pai, passando a ver os pais concretos pela primeira vez na vida, sem se relacionar com eles como dois malucos e sim como duas pessoas que, dentro de várias adversidades, lutaram para construir uma família, e como apesar das brigas ferrenhas entre os pais, foram “anjos” um na vida do outro. O pai foi um “anjo” porque possibilitou que a mãe fosse para uma cidade maior, se casasse, trabalhasse; a mãe, por apoiar e lutar com o pai para que ele tivesse reconhecimento e justiça relativamente ao seu trabalho. Mostramos à paciente que ela e os irmãos resultaram de toda a luta e sofrimento dos pais em viabilizá-los como família e como pessoas que pudessem prosperar. O objetivo metodológico desta localização era de que a paciente recuperasse as suas raízes, visando acabar com o complexo de ser excluída tanto na família quanto fora dela, possibilitando que ganhasse segurança de ser e objetividade na sua vida de relações – mostrando que, na verdade, a experimentação de ser no abandono foi a apropriação possível para uma menina de cinco anos, mas em realidade nunca foi abandonada,

tanto que foi provida e cuidada pelos pais até a vida adulta, e inclusive atualmente, desfrutando das posses que os pais conseguiram conquistar e que já haviam doado aos filhos ainda em vida.

A paciente passou a conseguir lidar com melhor tranquilidade com os pais após essas localizações, inclusive conseguindo passar as primeiras festas de final de ano sem entrar em confronto, sem tentar mudar as atitudes dos familiares e sim buscando driblar as situações que poderiam ser incômodas ou conflituosas e conviver socialmente destacando aquilo que os unifica como família, tratando de assuntos amenos, de lembranças agradáveis e voltando-se com os familiares ao entretenimento com as gracinhas das crianças.

Com relação à troca de escola da filha, a menina foi tendo as dificuldades esperadas para quem está estudando, ainda mais que estava se recuperando das pequenas defasagens que resultaram do período em que teve as complicações decorrentes das crises de amigdalite. A paciente passou a conseguir lidar normalmente com o desempenho da filha na escola nova. Anteriormente, qualquer dificuldade da filha a colocava em pânico, na intuição de que a filha enfrentaria as mesmas dificuldades escolares que ela teve na sua infância, tendo ao fundo a intuição de que a filha tinha ou teria algum problema mental, tal qual também fora a suspeita dela a respeito de si mesma, por muito tempo. Para que se localizasse desses

equivocos e interpretações, levantamos detalhadamente a situação da paciente quando criança e a situação da filha, mostrando que a história das duas é totalmente distinta, mas que igualmente as duas resultaram das possibilidades de seus contextos. A paciente teve os pais que brigavam muito, enfrentou uma infância com pai alcóolatra, a falência do pai que os colocou em necessidade e escassez maior em alguns momentos da vida, pais com pouca instrução, várias mudanças de escola em um curto espaço de tempo, não acompanhamento em suas dificuldades escolares, e nem orientação de alguém ao fazer as tarefas. A realidade da filha é totalmente outra, tem pais com boa instrução, com condição material estável, estuda numa segunda escola, mas coincidindo com a entrada no primeiro ano, e é acompanhada em todas as tarefas escolares, os pais participam dos eventos na escola, tem aula particular, etc. Este levantamento permitiu que a paciente iniciasse sua localização quanto a realidade de cada uma delas ser distinta. As histórias de vida delas seriam semelhantes se, e somente se, seus contextos tivessem sido muito parecidos.

Não obstante todas essas localizações, a paciente seguia com medos que não se sustentavam na realidade, antecipando um destino desastroso para ela e a filha, que experimentava como uma espécie de castigo que não permitiria que ela conseguisse ser bem-sucedida em sua família e profissão. Identificamos que a paciente padecia de uma dificuldade na sua relação com Deus, se

experimentava tendo sido uma menina má, e que, por conta disso, a qualquer momento seria castigada. Elenizamos com a paciente a série de situações que compreendia como sendo maldades e pecados seus da infância. Levantamos a vida religiosa dela e identificamos que viveu dentro de um forte clima religioso: a mãe foi catequista e participava de muitas pastorais e a paciente também cresceu nesse contexto, participando assiduamente das missas e de atividades relacionadas à igreja. Sendo assim, aprendeu sobre pecado e castigo e, algumas das coisas que tinha feito quando criança e sabia serem pecados conforme o aprendizado religioso que tinha, não confessou na primeira comunhão por temer ser castigada por Deus. Mas justamente por não ter se confessado desses “pecados”, ficou na certeza de não ter sido perdoada e, por isso, fadada a ser castigada, por também aprender sobre um Deus onipotente, onipresente e onisciente. A maioria das situações que a faziam se experimentar pecadora diziam respeito à sexualidade praticada em brincadeiras sexuais na infância, e o fato dela não poder ignorar que buscava o prazer das situações. Essas situações reforçaram o medo do abandono que vivia em relação à família de origem e à família atual, encontravam ancoragem ainda mais profunda, fazendo com que se experimentasse abandonada por Deus, indigna de proteção.

Primeiramente esclarecemos como funciona a sexualidade na infância e como a criança busca o prazer sem

ter a consequência em relação ao que está fazendo, e que apenas posteriormente vai entender a sua atitude como pecado, conforme a indução dos adultos, da religião, etc. Porém, o prazer de ato é próprio de qualquer pessoa que se permita senti-lo, e que isso não define nada em termos de sexualidade, que vai depender do sistema de vida que a pessoa adota. O segundo ponto em relação a esta questão dos “pecados da infância” foi providenciarmos um relatório elencando todas as ocorrências que faziam com que a paciente se condenasse e a encaminhamos para conversa com um religioso que a esclarecesse quanto às suas possibilidades na relação com Deus.

Após esta iniciativa de conversa com o religioso a paciente experimentou-se bastante tranquila por ter exposto tudo que em outras confissões tinha omitido, e por compreender Deus como uma figura misericordiosa, ao invés do Deus punitivo que acabou aprendendo na sua infância. Passou a rezar sem se experimentar em falso e a ter tranquilidade de ensinar as orações para a filha. Passou a se sentir mais normal, homem entre os homens, e não mais em grande euforia ou frustração, oscilação na qual entrava quando acontecia algo bom, em que, na sequência, intuía que não era para ela, por ser alguém condenada a não dar certo, por ser má ou por estar abandonada por Deus.

Ao longo de todo o processo psicoterapêutico, como prevê a metodologia, a paciente foi evoluindo e passou a

ter um movimento nas relações que era inédito em relação ao que sempre ocorreu nos 45 anos anteriores. Na relação com a filha, passou a lidar com tranquilidade, conseguindo acompanhar as tarefas e provas da filha sem assustar-se; começou a demarcar limites para a filha, para que aprendesse a dar-se limites por dentro, sem entrar em acessos emocionais com medo de perder o amor da filha, deixou de entrar em euforia e depressão diante de acertos ou erros da filha, pois ora lidava com a filha como genial diante de comportamentos normais de uma criança de sua idade, e ora lidava como sendo um “retardo” diante também de comportamentos e dificuldades normais de uma criança de sua idade. Passou então a relacionar-se com uma filha normal, com dificuldade e possibilidades próprias das crianças de sua idade. A filha passou a socializar-se na escola e a mãe passou a permitir que a filha estabelecesse amizades e fosse à casa das amigas como também as recebesse em casa, participasse de festinhas de aniversário, coisa que nunca tinha ocorrido anteriormente.

A paciente também saiu da experimentação de exclusão, passando a transitar cada vez mais normalmente entre outros adultos, frequentando eventos sociais com as mães das amigas da filha; participando das conversas entre mães e com os seus parentes nas redes sociais; indo a aniversários e comemorações de alguns amigos com os quais não alimentava relação há muito tempo, tudo isso sem experimentar o constrangimento de outros momentos.

Nas relações familiares a convivência foi tornando-se cada vez menos tumultuada, sem que se irritasse ou comprasse brigas com os irmãos, aprendendo a habilidade de conversar sobre coisas leves, sobre coisas cotidianas, sem gerar ou alimentar polêmicas políticas ou comportamentais. Passou a compreendê-los em seus limites, sem entrar na tarefa de “educá-los” conforme o que entendia ser certo, conseguindo então mover-se mais como irmã dos irmãos e filha do seu pai e sua mãe, no sentido sociológico dos termos, deixando de estabelecer relações administrativas. Assim, conseguiu participar das festas de Natal, dos aniversários e das férias em família com tranquilidade, sem ficar o tempo todo na tensão que ocorria antes e que tornava a convivência muito exaustiva.

Com o marido, a relação veio avançando bastante, com o aprimoramento da comunicação entre eles, passaram a conversar sobre os assuntos da casa, das refeições e contas, minimizando a queixa dele de que ela não se posicionava e o deixava sozinho com as decisões sobre a família, coisa que de fato ela fazia por medo de posicionar-se. Passou a conseguir expressar seus desejos e necessidades em coisas simples, como em relação ao cardápio das refeições, passaram a combinar a divisão das tarefas domésticas, mas com ela também se posicionando sobre momentos em que não conseguiria corresponder às expectativas dele quanto à arrumação da casa, os cuidados com a filha, a organização das refeições, por ter também que conciliar essas

atividades com o seu trabalho profissional, no qual vinha avançando e por isso consumia-lhe mais tempo. Passou a conseguir se posicionar frente ao marido sem entrar em pânico de ser abandonada por desagradá-lo. Deixou de omitir pequenas coisas que antecipava que fossem trazer conflito, e passou a buscar um consenso entre eles. Passou a permitir um maior envolvimento do marido com a filha deles, pois seus medos a faziam superprotegê-la e tomar para si os cuidados de alimentação, saúde e tarefas escolares. Assim, o pai passou a fazer algumas tarefas e trabalhos com a filha, e foi demonstrando sua satisfação com essa possibilidade de ser um pai mais atuante, bem como a satisfação de percebê-los mais companheiros e combinando mais as coisas da família.

Na sua atividade profissional, a paciente também avançou de modo a não entrar em pânico nas situações que antecedia seu trabalho e tampouco entrar na euforia ou frustração dependendo do que acontecesse no trabalho. Acabava reagindo dessa forma anteriormente, o que era inadequado em termos de normalidade emocional, pois, assim como via num resultado positivo a superação de todos os problemas, via num pequeno obstáculo a condenação a um fracasso. Progressivamente, foi aprendendo a lidar com os acontecimentos positivos e negativos, dentro da normalidade, como parte integrante da realidade objetiva, e com isso foi avançando na retomada de sua carreira e estabelecendo-se como

profissional que havia abandonado fazia mais de 15 anos, poucos anos após graduar-se, por ter se experimentado incapaz de exercer a profissão.

Localizamos a paciente de que todos esses avanços apontavam para a modificação de sua personalidade, com conquistas que alcançavam todos os seus perfis. Também chamamos o marido para uma série de sessões em conjunto com o objetivo de fazer a apropriação com os dois de todos estes avanços, para com isso reforçar o sociológico entre eles e para que os avanços familiares fossem ainda maiores. Precisávamos que se localizassem da situação atual dela e da situação atual da vida deles, mostrando que era outra realidade do que a que tínhamos quando a paciente chegou à terapia. Mostramos como a situação psicológica da paciente estava em vias de total recuperação e, como consequência, os acessos emocionais de que padecia ao início da terapia estavam se extinguindo, com a paciente ficando, a olhos nus, diferente nos seus diversos perfis. Recuperamos com os dois uma série de episódios atuais e do passado, mostrando a diferença na relação da paciente com a filha, com o trabalho, com seus progenitores, com o próprio marido, com a casa e com ela própria, que passou a se cuidar mais, inclusive em termos estéticos. Também localizamos, pois eram preocupações do marido, como a família estava em vias de recuperação e inclusive em melhores condições de superar algumas dificuldades materiais, na medida

em que o marido deixava de ser o exclusivo provedor da família, podendo contar agora com o trabalho profissional da esposa, que vinha se tornando gradualmente mais promissor. Buscar colocá-los diante da situação em que se encontravam atualmente tinha vistas a abrir ainda mais a esperança quanto a um futuro melhor. Nos comentários, os pacientes referiram como a casa deles, que no começo do processo funcionava mais com uma clínica de saúde, com eles (e principalmente a paciente) como enfermeiros da filha, era agora uma família dentro da normalidade, e com perspectivas boas em todos os âmbitos – profissionais, financeiros e sociológicos.

Posteriormente a esse conjunto de sessões, fizemos mais um conjunto de sessões ao identificar que não obstante a paciente viesse em bastante progresso e em franca superação de seus episódios emocionais, ocorriam ainda vários conflitos com o marido, agora provocados por intransigências dele, que o faziam lidar na relação com a paciente desqualificando-a, quando as atitudes tomadas por ela estavam dentro dos padrões objetivos. Identificamos que a paciente havia superado seus padecimentos, mas que seu marido ainda desqualificava certas ações da paciente interpretando-as como atitudes daquela mulher que ela tinha sido, insegura, dispersa, sem posição, medrosa. Descrevemos estes episódios e desmontamos seus equívocos, localizando-o de estar agindo com a esposa como sendo aquela

mulher que fora no passado, quando atualmente ela estava noutra situação, e na normalidade emocional. O marido se localizou e mudou bastante suas atitudes, o que converteu a vida deles em família numa vida efetivamente sociológica, com mais tranquilidade e afetividade. Aqui identificamos também certas dificuldades do marido, decorrente de uma história familiar muito sofrida, com muitas mortes e doenças graves, que o faziam experimentar-se solitário, mesmo que as atitudes da esposa já não justificassem isso. Para a superação destas dificuldades, seguimos o trabalho em psicoterapia individual com ele, para torná-lo mais seguro para as relações atuais em sua família transcendente à família de origem.

Com relação à filha, a menina encontra-se muito bem, não repetiu nenhum ano escolar, encontra-se no quinto ano do ensino fundamental, com um aproveitamento ótimo, bastante esperta e inteligente, com boa socialização na escola e fora dela, com convivência com as amiguinhas e familiares dentro da normalidade. Ajuda em casa arrumando suas coisas, faz algumas comidas, opina e envolve-se na vida familiar. Continua muito saudável, com pouquíssimas intercorrências de saúde, e todas muito leves, confirmando a cada dia a importância da verificação e diagnóstico de seu quadro de amigdalite como sendo o desencadeador das convulsões e de todos os problemas que vinham como desdobramento

das infecções. Esse passo do processo psicoterapêutico foi crucial para o desfecho do caso, e ratifica mais uma vez o fundamental aspecto de nossa metodologia, que é a intervenção interdisciplinar. Pois, não obstante todo o problema psicológico da paciente, enquanto sua filha encontrava-se em situação de saúde delicada, a paciente não tinha condições de envolver-se sequer com seus próprios sofrimentos psicológicos. Confirmando, mais uma vez também o que preconiza a metodologia, que iniciemos a intervenção psicoterapêutica pelo momento atual da vida do paciente, resolvendo os impasses primeiramente advindos desse momento atual, para depois encontrar no passado as determinantes para aqueles problemas que não encontram as determinantes em elementos do contexto presente.

Com a recuperação psicológica da paciente, com a superação de sua relação com o passado, com os avanços da filha e com os avanços do sociológico familiar, seguimos com a paciente em acompanhamento psicoterapêutico para a consolidação de todas estas conquistas e para aprofundar um pouco mais a relação do casal, a partir dos avanços que vão sendo alcançados com o marido em psicoterapia. Seguimos também com os relatórios sistemáticos ao médico psiquiatra, informando da evolução da paciente, e ele vem gradualmente reduzindo a medicação, que já está num mínimo de dosagem e na sequência será totalmente suspensa, coincidindo com o

que compreendemos do processo psicoterapêutico: que o paciente recuperado consegue seguir bem sua vida e não precisa mais do auxílio da medicação a partir do momento em que consegue resolver as intercorrências de suas relações com segurança psicológica, porque estabelecido num novo saber de ser, que agora coincide com as possibilidades da realidade atual, da realidade objetiva.